

6 胸痛 chest pain

到達目標

- 胸痛をきたす原因疾患を列挙できる
- 胸痛の原因を鑑別する検査を列挙できる
- 胸痛の治療について概説できる

定義

胸部に生じる疼痛であるが、原因となる臓器には心・大血管、肺またはその他の胸腔内臓器、頸部・胸郭、肩の筋肉、骨格、腹部内臓器がある。

a 病態と原因疾患

組織傷害の結果生じる組織緊張や化学的な因子などが、痛覚神経末端を刺激することによって胸痛が生じる。胸痛の分類としては、発生源により表在痛（胸壁由来の胸痛）と深部痛（内臓由来の胸痛）に分けられ、また臓器別に分類されることもある。表1に臓器別の胸痛をきたす疾患を示す。

診断

a 病歴・問診

i) 胸痛の性状

1) 胸痛の訴えはいつから始まり、どのようなときに出現または増強するか

反復性の前胸部痛で労作時に増強すれば労作性狭心症を疑う。胸痛が深呼吸や体動によって生じたり増強する際には、胸膜炎や肋骨骨折の胸膜・胸壁疾患を考慮する。

2) 痛みの部位はどこが一番強いのか、また痛みは放散するか

前胸部に激しく持続的な痛みを訴えているとき、左肩や頸部に放散する場合には、急性心筋梗塞が考えられる。大動脈解離、肺血栓塞栓症・肺梗塞、急性心膜炎を鑑別し、気胸、縦隔気腫も念頭におく。胸骨裏面に痛みがあり、咳、体位変化により痛みが増強する場合、心膜炎を考慮する。

3) 痛みの持続時間および一過性なのか持続痛なのか

短時間の中等度の痛み発作が繰り返される際には狭心症を疑い、筋肉・骨の痛みあるいは神経痛や不安状態を鑑別する。

4) 痛みの性質

圧迫性、緊張性、拍動性、放射性、牽引性、刺痛性、痙攣性、絞扼性、灼熱性、電撃性などがある。

5) 随伴症状の有無

発熱、呼吸困難、動悸、咳、嘔気・嘔吐、腹痛の有無を聴取する。発熱を伴うような側胸壁の痛みは胸膜炎を疑う。咯血や血痰を伴う激痛は大動脈瘤破裂や大

動脈解離、肺血栓塞栓症・肺梗塞を疑う。

ii) 既往歴と治療歴

心筋梗塞、高血圧症、糖尿病、高脂血症、さらには気胸や带状疱疹などの既往と治療について聴取する。

iii) 生活習慣

喫煙、食生活、職業歴なども聴取しておく。

b 身体所見

i) バイタルサイン

血圧、呼吸、脈拍に注意する。

ii) 視診

顔貌と姿勢、胸郭の変形や脊柱の異常、呼吸運動の左右差、皮膚異常の有無を診ておく。

iii) 圧・打診

筋肉や骨格系の腫脹や圧痛の有無を確認しておく。圧痛を証明できれば、深在性の内部臓器の異常ではない。

iv) 聴診

心音の異常や心雑音に注意する。収縮中期クリックや収縮中期雑音は僧帽弁逸脱症の診断に有用で、連続雑音はValsalva洞動脈瘤破裂の際に聴取される。一方、心膜摩擦音は心膜炎の診断に有用である。片側性の呼吸音減弱は気胸の診断上重要な所見である。

v) 触診

心尖拍動の触知による部位と広さは心拡大の大まかな目安となる。また、腹部の圧痛や腫瘍の有無についても診察しておく。

検査

a 胸部X線および胸部・腹部CT

胸部X線写真は自然気胸や胸膜炎の診断には有用であり、縦隔陰影の拡大は解離性大動脈瘤を疑うきっかけとなる。また、胸部・腹部CTは解離性大動脈瘤や肺実質、心膜あるいは胸膜疾患の診断のみならず、胆石症など腹部症状の診断にも有効である。

b 心電図

狭心症、急性心筋梗塞、心膜炎、肺血栓塞栓症・肺梗塞では疾患特異性のある心電図変化を認める。

c 超音波検査

心エコーは心電図で判断が難しい心筋梗塞・肺梗塞、心嚢液貯留を確認できるとともに、肥大型心筋症や僧帽弁逸脱症の診断が可能である。また、腹部エコーは肝・胆・脾疾患の診断に有用である。

d 血液検査

CBC、CRP、AST、ALT、LDH、CK、CK-MB、トロポニン-Tは急性心筋梗塞診断に、D-ダイマー値の上昇、動脈血ガス分析による低酸素血症は肺血栓塞栓症・肺梗塞の診断に有用である。感染症が原因となる